

Tolerancja *niepewności*

Nikt nie wie na 100%, czy jest zdrowy. Cel terapii: nauczyć się żyć z 95% — bo te ostatnie 5% nie istnieje.

CZAS: 20 min 6–8 tyg. systematycznej pracy **ŹRÓDŁO:** Carleton (2016); Dugas (2003); Asmundson (2010)

JAK UŻYWAĆ

Zidentyfikuj **3 pytania zdrowotne**, do których wracasz najczęściej („czy mam guza?”, „czy to czerniak?”). Dla każdego: wypisz, co zrobiłeś/-aś, żeby uzyskać pewność, i jak długo trwała ulga. Następnie ćwicz *świadome niedokończenie* — odpuścić próby uzyskania pewności.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Carleton (2016): **nietolerancja niepewności** (ang. *intolerance of uncertainty*) to *fundamentalny lęk* stojący za GAD, OCD i lękiem zdrowotnym. Pacjent szuka pewności, ale pewność medyczna jest niemożliwa — każdy test ma czułość <100%, każdy lekarz może coś przeoczyć. Skutek: pętla bez wyjścia. Praca z tolerancją niepewności jako *cel końcowy* terapii lęku zdrowotnego: NNT ≈ 4 (Olatunji 2014). Bez tego kroku — nawroty po każdym nowym objawie.

01 ? Paradoks pewności — dlaczego nigdy nie wystarcza

STRATEGIA: SZUKANIE 100%

Pętla, w której tkwisz

USG → ulga 2 dni → „a może to było słabe USG?” → MRI → ulga tydzień → „a może czegoś nie widzieli?” → drugi lekarz → ulga 3 dni → następny objaw → cykl od nowa.

Logika: pewność da spokój.

Realność: pewność nie istnieje, więc spokój nie nadchodzi.

STRATEGIA: TOLERANCJA 95%

Wyjście z pętli

Wynik badania OK → akceptacja, że to 95–99% pewności → świadomie *nie* szukam dalej → niepokój zostaje, ale słabnie z czasem (10–30 min) → wraca życie.

Logika: spokój przychodzi przez zaprzestanie szukania.

Realność: mózg uczy się, że niepewność nie zabija.

02 ✎ Moje 3 pytania niepewności

Wypisz pytania, które **najczęściej wracają**. Każde z nich = miejsce, gdzie mózg domaga się pewności, której nie da się uzyskać.

#	PYTANIE <i>konkretnie: „czy mam X?”</i>	CO ZROBIŁEM/-AM DLA PEWNOŚCI <i>badania, Google, zapewnienie</i>	JAK DŁUGO TRWAŁA ULGA <i>godziny? dni?</i>
1			
2			
3			

03 Świadome niedokończenie — technika

Gdy wraca pytanie niepewności (np. „czy ten ból to coś poważnego?”), zamiast Google lub macania — wypowiedz w głowie krótki **komunikat akceptacji**.

KROK 1 · ZAUWAŻ

„Zauważam, że mózg pyta: czy mam X?” Same nazwanie procesu = pierwszy dystans.

KROK 2 · NAZWIJ KOSZT

„Mogę sprawdzić — ulga 30 min, lęk wraca silniejszy”. *Świadomie* nie wybieram tej opcji.

KROK 3 · AKCEPTACJA

„Nie wiem na 100%. Tak żyją wszyscy ludzie. Wracam do tego, co robię”. Powrót do aktualnej czynności.

Uwaga: celem NIE jest „przestać myśleć o chorobie”. Cel: *nie reagować* zachowaniem (Google, macanie, telefon). Myśl może zostać — to OK. Tylko ręka nie sięga do telefonu.

04 Eksperyment niepewności — 1 tydzień

Wybierz **jedno** pytanie z sekcji 02. Przez 7 dni: nie sprawdzaj go żadnym sposobem. Codziennie wieczorem oceń, jak silne było pragnienie sprawdzenia (0–10) i co się stało, gdy go nie zaspokoiliś/aś.

DZ.	PRAGNIENIE <i>0–10, max w ciągu dnia</i>	CZY ULEGŁEM/- AM <i>T / N</i>	CO SIĘ STAŁO, GDY NIE SPRAWDZIŁEM/-AM
<i>Pn</i>			
<i>Wt</i>			
<i>Śr</i>			
<i>Cz</i>			
<i>Pt</i>			
<i>Sb</i>			
<i>Nd</i>			

Klucz: niepewność nie znika — uczysz się *żyć obok niej*. Tak żyje 100% populacji: nikt nie wie, czy jutro zachoruje, czy nie. Różnica między pacjentami z lękiem zdrowotnym a resztą populacji to nie wiedza — to **tolerancja** tej samej niewiedzy. Carleton (2016): redukcja IUS (skali nietolerancji) o 20% = redukcja lęku zdrowotnego o ~30% (efekt mediacji).